

UNIDAD 1. 1

ÍNDICE.

00. Ley 26.657 - Salud pública - Derecho a la Protección de la Salud Mental.

Disposiciones complementarias. Derogase la Ley N° 22.914 (Ley de Salud Mental)

1. Stolkiner, A. "Teórico N.º 4: El Concepto de Salud de la OMS".
2. Stolkiner, A. y Ardila Gómez, S. "Conceptualizando la Salud Mental en las prácticas: Consideraciones desde el pensamiento de la medicina social. Salud Colectiva latinoamericana".
3. Tajer. "La Medicina Social LATAM en los '90. Hechos y Desafíos".
4. Augsburger, C. "De la epidemiología psiquiátrica a la epidemiología en salud mental. El sufrimiento psíquico como categoría clave".
5. Vasco Uribe, A. "Estructura y Proceso en la conceptualización de la enfermedad".
6. Caponi S. (2010) Georges Canguilhem. "Del cuerpo subjetivo a la localización cerebral".
7. Tajer, Débora. "Cuidados Generizados en Salud".
8. Ceminari, Y., Stolkiner, A. "El Cuidado Social y la Organización Social del cuidado como categorías claves para el análisis de políticas públicas".
9. Ley nacional N° 26.657.
10. Menéndez, E. (2003). "Modelos de atención de los padecimientos de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas".
11. Michalewicz, Pierri, Ardila. "Del Proceso 'Salud - Enfermedad - Atención' al Proceso 'Salud - Enfermedad - Cuidado'. Elementos para su conceptualización".

Teóricos y Prácticos. “Salud Pública y Mental” Cát.: TAJER.

04 – Ley 26.657 - Salud pública - Derecho a la Protección de la Salud Mental.

Disposiciones complementarias. Derogase la Ley N° 22.914.

RESUMEN DETALLADO

Título del texto analizado: Ley 26.657 - Salud pública - Derecho a la Protección de la Salud Mental. Disposiciones complementarias. Derogase la Ley N° 22.914

La Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657), sancionada en Argentina en el año 2010, establece un cambio de paradigma radical en el abordaje del padecimiento psíquico. Su idea central es el abandono definitivo del modelo asilar, tutelar y puramente biomédico, para instaurar un modelo comunitario, interdisciplinario y profundamente arraigado en los derechos humanos. De este modo, la norma busca garantizar la inclusión social y reconocer a las personas con padecimiento mental como sujetos plenos de derecho, priorizando siempre su autonomía y la presunción de su capacidad jurídica.

Para comprender esta transformación, es fundamental partir de la nueva concepción de la salud mental. La ley la define no como un estado biológico estático o la mera ausencia de enfermedad, sino como un proceso dinámico determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Bajo esta perspectiva de derechos humanos, se prohíbe explícitamente emitir diagnósticos basados en prejuicios, tales como el estatus social, las creencias religiosas, la identidad sexual o la mera existencia de antecedentes psiquiátricos. Asimismo, la normativa incorpora el abordaje de las adicciones (el uso problemático de drogas legales e ilegales) como parte constitutiva e inescindible de las políticas de salud mental, garantizando a estos usuarios los mismos derechos y resguardos que al resto de los pacientes.

En cuanto a la modalidad de atención, el texto legislativo exige un abordaje interdisciplinario. Esto significa que el tratamiento deja de estar hegemonizado exclusivamente por la figura del médico, para pasar a estar a cargo de un equipo donde diversas disciplinas —como la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, la enfermería y la terapia ocupacional— intervienen en igualdad de condiciones para la toma de decisiones y la gestión. Este equipo debe priorizar siempre el abordaje ambulatorio y el mantenimiento de los lazos sociales del paciente, requiriendo su consentimiento informado para cualquier intervención y garantizando que reciba la alternativa terapéutica que menos restrinja sus libertades.

Uno de los ejes más innovadores y transformadores de la ley es la desinstitutionalización, que marca el fin de los asilos tradicionales. La normativa prohíbe terminantemente la creación de nuevas instituciones monovalentes (es

decir, hospitales neuropsiquiátricos cerrados dedicados exclusivamente a una patología) y ordena que los ya existentes se adapten progresivamente hasta ser sustituidos de manera definitiva por dispositivos alternativos de base comunitaria, como hospitales de día, casas de convivencia y emprendimientos sociolaborales. En consecuencia, se establece que cualquier internación de salud mental que deba llevarse a cabo tendrá lugar en los servicios de los hospitales generales, prohibiendo expresamente el rechazo de pacientes por motivos psiquiátricos.

En este nuevo esquema, la internación pasa a ser considerada un recurso terapéutico de carácter restrictivo y excepcional. Ya no es el destino primario ni la respuesta a problemáticas sociales o de vivienda, sino una medida extrema que debe ser lo más breve posible. Particularmente, la internación involuntaria (aquella que se realiza sin el consentimiento válido del paciente) solo puede justificarse cuando un equipo interdisciplinario dictamina que existe un riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros. Para evitar privaciones de libertad arbitrarias, el diagnóstico de una afección mental nunca autoriza por sí mismo a presumir riesgo de daño o incapacidad; toda internación involuntaria está sujeta a plazos estrictos de notificación y a un riguroso control judicial continuo.

Finalmente, para velar por el cumplimiento de todas estas garantías, la ley estipula la creación del Órgano de Revisión en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa. Esta entidad, conformada por representantes estatales, profesionales, asociaciones de usuarios, familiares y organizaciones de derechos humanos, tiene la función ineludible de supervisar las condiciones de internación de oficio, evaluar la pertinencia de los tratamientos prolongados y proteger los derechos de los usuarios frente a posibles abusos institucionales. En definitiva, la ley consagra el paso de un sistema históricamente enfocado en el encierro y la marginación hacia uno que promueve el cuidado integral, la recuperación en el marco de la comunidad y la preservación inalienable de la dignidad de las personas.

Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

07 – Stolkiner, Alicia. "teórico N.º 4. "El concepto de salud de la OMS".

RESUMEN DETALLADO.

La clase teórica dictada por Alicia Stolkiner desarrolla una profunda deconstrucción crítica de la célebre **definición de salud de la OMS** formulada en la posguerra: "el estado de completo bienestar físico, psíquico y social y no sólo la ausencia de enfermedad". El argumento central del texto sostiene que esta formulación no debe asumirse como una verdad teórica absoluta o un dogma científico, sino que debe ser analizada mediante una **deconstrucción histórica y política**. Al aplicar esta herramienta, se evidencia que el concepto nace estrechamente ligado al modelo keynesiano del Estado de Bienestar. En este contexto, el "bienestar" no aludía primordialmente a un sentimiento intrasubjetivo, sino a las condiciones materiales de vida necesarias para el desarrollo humano (agua potable, vivienda digna, educación), cuya provisión y garantía recaían como una responsabilidad activa sobre el Estado.

A pesar de su valor histórico para cuestionar la hegemonía del modelo estrictamente médico y biológico, la definición de la OMS ha sido objeto de severas críticas. En primer lugar, desde el campo de la medicina social, se objeta la concepción estática del concepto; por el contrario, se postula la **salud como proceso**, entendiéndola como una dinámica permanente que no puede reducirse a un estado definitivo a recuperar. En segundo lugar, surge una fuerte **crítica psicoanalítica al "completo bienestar"**. Basándose en los postulados freudianos, se argumenta que la satisfacción absoluta es una utopía inalcanzable, asimilable al nirvana o a la pulsión de muerte, ya que un cierto grado de tensión, carencia o malestar es inherente a la condición humana y resulta el motor indispensable para la vida. En tercer lugar, desde la perspectiva de la **crítica desde la salud del trabajador**, se advierte que "sentirse bien" no siempre es un indicador de sanidad. La adaptación asintomática a un entorno nocivo o deteriorante a menudo implica la mutilación de capacidades vitales —como un obrero que deja de sufrir por el ruido extremo únicamente porque ha perdido la audición—, convirtiendo a esa aparente falta de malestar en un claro indicador de enfermedad.

Al abrir el espectro de la salud hacia lo psíquico y lo social, la propia definición de la OMS hizo insostenible la explicación de los padecimientos desde un enfoque exclusivamente biológico e individual. Esta superación del reduccionismo exige recurrir a la **interdisciplina**, es decir, al trabajo articulado y transversal entre diferentes campos del saber. Para fundamentar esta necesidad operativa y conceptual, la autora recurre al **Paradigma de la Complejidad (Sistemas Complejos)** teorizado por Rolando García. Este paradigma ilustra que los

fenómenos catastróficos o epidemiológicos no admiten explicaciones lineales; tal como demuestra el análisis de una sequía devastadora en África, las consecuencias letales no derivaron meramente de un factor natural como la falta de lluvia, sino de una intrincada red de variables económicas, políticas y sociales, como la sedentarización forzada de poblaciones nómades. En definitiva, la comprensión del proceso de salud y enfermedad obliga a abandonar los recortes aislados para asumir un enfoque complejo, reconociendo que el bienestar humano es el resultado de múltiples determinaciones entrelazadas que solo pueden abordarse mediante la colaboración conjunta de las ciencias.

Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

08 – Stolkiner, Alicia; Ardila-Gómez, Sara. "Conceptualizando la salud mental en las prácticas: consideraciones desde el pensamiento de la medicina social/salud colectiva latinoamericanas".

RESUMEN DETALLADO.

El artículo de Alicia Stolkiner y Sara Ardila-Gómez postula que la "salud mental" no debe definirse como una entidad estática, aislada o puramente biológica, sino que debe comprenderse en la complejidad de un entramado histórico, social y subjetivo. Este análisis se fundamenta en la Medicina Social y la Salud Colectiva Latinoamericana, una corriente de pensamiento y acción política surgida en los años setenta que rompió con el modelo positivista y biologista de la Salud Pública tradicional. Para esta corriente, la salud no es simplemente la ausencia de enfermedad, sino que se enmarca en el "proceso salud-enfermedad-cuidado". Esta noción dinámica supera la vieja dicotomía médica al incorporar el cuidado, un término que denota relaciones horizontales y participativas, reconociendo que las formas en las que la sociedad responde a los padecimientos son también productoras de dicho proceso.

Desde esta perspectiva, las autoras critican severamente las lógicas actuales del mercado y la "biopolítica", entendida como el conjunto de mecanismos mediante los cuales los rasgos biológicos humanos se convierten en estrategias de poder político y económico. En el campo sanitario, esto se materializa a través de la "medicalización de la vida", una tendencia creciente a subordinar todas las esferas de la vida cotidiana, el malestar natural y las singularidades al discurso médico-científico y farmacológico. Este fenómeno es impulsado por el "neobiologismo", un discurso contemporáneo que, apoyado en determinismos biológicos o en manuales psiquiátricos como el DSM-V, reduce la complejidad del padecimiento a una única causa orgánica o crea categorías de enfermos "pre-sintomáticos". Estas lógicas invisibilizan los determinantes sociales e históricos del sufrimiento humano, transformando la vida misma en un objeto mercantil y de control.

Frente a este escenario de mercantilización, la corriente latinoamericana contrapone una ineludible "perspectiva de derechos". Esta visión concibe a la salud no como un bien de consumo, sino como un derecho humano y social fundamental que exige la acción pública estatal y el acceso universal. En el terreno específico de la psiquiatría y la psicología, el enfoque de derechos obliga a desplazar el eje de intervención: ya no se trata de centrarse en la patología como un ente aislado, sino de enfocarse en el sujeto. Por ello, se propone abandonar la etiqueta clasificatoria de "enfermedad mental", que perpetúa la división mente-cuerpo, para adoptar el concepto de "padecimiento subjetivo" o "sufrimiento psíquico". Este cambio

terminológico y conceptual enfatiza la dimensión singular, histórica y vincular del dolor humano.

Finalmente, las autoras advierten que las reformas en salud mental atraviesan una tensión ineludible entre la "objetivación" y la "subjetivación". La objetivación ocurre cuando el sistema y las disciplinas reducen al paciente a un cuerpo biológico intervenible o a un cliente consumidor de psicofármacos. Por el contrario, la subjetivación implica reconocer al otro en su dimensión vincular y como pleno sujeto de derechos. Transformar genuinamente las prácticas en salud mental exige dismantelar no solo los muros de los manicomios, sino también los dispositivos objetivantes instaurados en las profesiones, recuperando el vínculo intersubjetivo como la verdadera herramienta terapéutica y ética del cuidado.

Teóricos y Prácticos. “Salud Pública y Mental” Cát.: TAJER.

11 – Débora Tajer. “**La medicina social latinoamericana en los años noventa: hechos y desafíos**”.

RESUMEN DETALLADO.

El capítulo escrito por Débora Tajer analiza el desarrollo, la matriz conceptual y los desafíos de la Medicina Social Latinoamericana durante la década de mil novecientos noventa, tomando como eje el papel de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES). La autora sitúa los antecedentes del movimiento en la reformulación de la educación médica de los años cincuenta y en el clivaje crítico de finales de los sesenta, cuando se desmitificó el sesgo ideológico de la medicina preventiva y de la salud pública tradicional. Con la cooperación de figuras como Juan César García y la creación de programas de posgrado pioneros en México y Brasil a mediados de los setenta, el movimiento se consolidó formalmente en 1984 en Ouro Preto (Brasil). ALAMES se define como un movimiento social, político y académico sustentado en cuatro vertientes: una dimensión conceptual orientada a los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad-atención; una vertiente política vinculada a los procesos de emancipación continental; una estructura organizacional en red; y un principio ético de solidaridad e internacionalismo entre los pueblos.

Para comprender la especificidad de la Medicina Social Latinoamericana en comparación con la Salud Pública tradicional de corte positivista, Tajer sintetiza sus delineamientos centrales. En primer lugar, concibe a la población no como una suma aritmética de individuos aislados, sino como colectivos sociales atravesados por condiciones históricas. En segundo lugar, analiza el estar sano, el estar enfermo y las prácticas asistenciales no como estados biológicos discontinuos, sino como un proceso dinámico y dialectico denominado proceso salud-enfermedad-atención. En tercer lugar, jerarquiza las estructuras socioeconómicas, la clase social y las relaciones de producción y reproducción como los determinantes primarios de la morbilidad y la mortalidad. En cuarto lugar, postula una articulación indisoluble entre teoría y práctica (praxis) capaz de generar conocimientos científicos que respalden políticas públicas contrahegemónicas. Finalmente, combina metodologías cuantitativas y cualitativas para evitar el reduccionismo de los ensayos clínicos convencionales e incorpora aportes de las ciencias sociales contemporáneas.

Durante la década de mil novecientos noventa, el movimiento enfrentó la implementación masiva de las Reformas Sectoriales en Salud (RSS) de matriz neoliberal, impulsadas en toda la región por el Banco Mundial. La Medicina Social formuló una rigurosa crítica a estas reformas, las cuales reemplazaron la visión de

la salud como un derecho ciudadano universal por criterios de eficiencia fiscal y efectividad financiera. Las RSS promovieron la focalización de recursos mediante canastas o paquetes básicos de prestaciones mínimas para la población empobrecida, excluyendo la garantía de una atención integral. Asimismo, la descentralización y municipalización de los servicios de salud, realizada en una de las regiones más inequitativas del planeta, aumentó la fragmentación del sistema y profundizó las disparidades de calidad entre municipios ricos y pobres. La introducción de empresas aseguradoras privadas y la pérdida de rectoría de los ministerios de salud terminaron por subordinar la atención médica a la lógica del mercado.

Frente a la desestructuración sanitaria de los noventa, la Medicina Social Latinoamericana desplegó una intensa agenda académica y política. En el plano teórico, expandió sus investigaciones hacia áreas como la salud de los trabajadores, la epidemiología social, la violencia, la bioética y la equidad de género (a través de la Red de Género y Salud Colectiva de ALAMES). En el plano político, el movimiento operó un viraje estratégico decisivo: de la tradicional crítica abstracta al Estado capitalista se pasó a la intervención directa en la gestión pública local y municipal. Con el triunfo de partidos progresistas a nivel urbano, numerosos líderes del movimiento asumieron secretarías de salud municipales en ciudades como México DF (con Asa Cristina Laurell), Caracas (con María Urbaneja) y Bogotá (con Román Vega), articulándose en iniciativas como la Red Américas. Esta praxis local buscó "publificar lo público", concepto que implica reestructurar la gestión estatal para que cualquier decisión gubernamental o conflicto de intereses se resuelva siempre a favor de las necesidades de la población sobre las exigencias del mercado.

En conclusión, la Medicina Social Latinoamericana se consolida como un enfoque ético, político e interdisciplinario que entiende la salud en un sentido abarcador ligado a la calidad de vida. Su agenda actual reafirma la defensa de la salud como un bien público y un derecho inalienable de la ciudadanía, confrontando las definiciones discrecionales de la equidad y construyendo redes internacionales que garanticen la justicia social e integral en los sistemas sanitarios.

Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

01 - Ana Cecilia Augsburger. *De la epidemiología psiquiátrica a la epidemiología en salud mental: el sufrimiento psíquico como categoría clave.*

RESUMEN DETALLADO

Título del texto analizado: *De la epidemiología psiquiátrica a la epidemiología en salud mental: el sufrimiento psíquico como categoría clave.*

Autora: Ana Cecilia Augsburger.

1. La Idea Central del Texto

El artículo postula que la epidemiología (el estudio de la distribución y los determinantes de las enfermedades en las poblaciones) aplicada a la salud mental se encuentra estancada metodológicamente. Esto ocurre porque sigue basándose en clasificaciones médicas tradicionales que aíslan los síntomas del contexto social e histórico de las personas. La autora argumenta que, para comprender realmente los problemas actuales de salud mental de la población, es imperativo abandonar la categoría restrictiva de "enfermedad mental" y adoptar el concepto de "**sufrimiento psíquico**". Este cambio de paradigma permite visibilizar cómo las profundas crisis de las instituciones sociales (específicamente la familia y el trabajo) son las verdaderas generadoras del padecimiento contemporáneo.

2. Los límites de la psiquiatría tradicional: La crítica a la "Enfermedad Mental"

El texto inicia cuestionando los sistemas de clasificación vigentes a nivel internacional, conocidos como la **nosografía psiquiátrica** (específicamente la CIE-10 de la OMS y el DSM-IV de la Asociación Americana de Psiquiatría). Estos manuales operan agrupando los problemas de salud mental bajo la categoría de "**trastorno mental**", definiéndolo como una disfunción biológica o del comportamiento que produce síntomas objetivos (aislables, medibles y observables).

Augsburger señala que este enfoque médico-biologicista presenta graves limitaciones:

- **Ausencia del sujeto:** Al buscar una "enfermedad objetiva" basada solo en síntomas observables, se ignora la experiencia subjetiva del paciente. Retomando la distinción teórica de M. Susser, la autora diferencia entre *disease* (la conceptualización abstracta que hace el médico de la enfermedad) e *illness* (la vivencia directa e interna que tiene el paciente de su propio mal). La psiquiatría clásica se queda solo con la primera.

- **Patologización de la vida cotidiana:** Aplicar el modelo causal de la medicina física a los problemas mentales lleva a etiquetar como "patologías" a conflictos que en realidad son respuestas emocionales a crisis vitales o sociales.

3. El "Sufrimiento Psíquico" y el "Malestar" como categorías superadoras

Para resolver las limitaciones de la nosografía clínica, la autora propone incorporar dos conceptos fundamentales que actúan como puente entre lo social y lo individual:

- **El Sufrimiento Psíquico:** Apoyándose en autores como Emiliano Galende, se define como el padecimiento emocional ligado a las frustraciones de la existencia, la soledad, los infortunios amorosos o el fracaso laboral. Estas son experiencias de dolor humano que no requieren ser traducidas a "procesos patológicos". El sufrimiento psíquico no es sinónimo de enfermedad; puede precederla o existir sin llegar a convertirse en un cuadro psiquiátrico clínico.
- **El Malestar:** Citando a la psicoanalista Mabel Burin y remontándose a Sigmund Freud (*El malestar en la cultura*), se introduce este concepto como una noción intermedia entre lo sano y lo enfermo. Es un estado de tensión derivado de los mandatos culturales y sociales incompatibles (por ejemplo, las condiciones opresivas de género). Freud ya advertía que la principal fuente de sufrimiento del ser humano proviene, paradójicamente, de los vínculos con otros seres humanos y de las normas sociales que, en teoría, deberían protegernos.

4. El anclaje social del sufrimiento: La crisis de las instituciones productoras de subjetividad

Augsburger enfatiza que no existe una psicología aislada de la cultura. La subjetividad (la forma en que una persona se construye, piensa y siente) se forja en instituciones fundantes. Actualmente, estas instituciones atraviesan transformaciones violentas que generan nuevas formas de padecimiento:

A. La Familia: La fragilización de los vínculos

La familia tradicional ha mutado, y aunque esto ha permitido cierta democratización y libertad, también ha generado labilidad y fractura en los vínculos. La autora ilustra esto con datos socioeconómicos de Argentina (y específicamente de Rosario), mostrando el aumento de hogares encabezados exclusivamente por mujeres. La sobrecarga material y afectiva sobre estas mujeres, sumada a la ausencia de figuras de contención sólidas para los niños, incrementa

el aislamiento social. La epidemiología demuestra que a mayor aislamiento y desprotección familiar, mayor es la prevalencia de problemas de salud mental.

B. El Trabajo: La incertidumbre y la pérdida de identidad

Retomando a Freud, el texto recuerda que el trabajo no solo tiene un valor económico, sino que es fundamental para la economía psíquica humana: ancla al sujeto a la realidad y le permite canalizar energías (libido). Sin embargo, el mercado laboral actual se caracteriza por la exclusión.

La desocupación, el trabajo precario ("en negro") y la subocupación destruyen lo que el investigador Miguel Matrajt llama el "proyecto existencial". Las estadísticas sanitarias de Rosario confirman que la depresión y la angustia —los principales motivos de consulta en adultos— están íntimamente ligados a la pérdida del empleo o a la inestabilidad laboral. El desempleo no es solo un contexto socioeconómico; es un factor directo de desintegración psicológica y marginación.

5. Conclusión General

La lectura integradora del artículo concluye que la epidemiología en salud mental debe dejar de ser una mera contabilidad de trastornos clasificados en manuales internacionales. Debe transformarse en una disciplina capaz de leer el **sufrimiento psíquico** de las poblaciones, entendiendo que fenómenos como la precariedad laboral, el desempleo y la crisis de los vínculos familiares no son el "telón de fondo" de la enfermedad mental, sino su principal motor de producción en la sociedad contemporánea.

Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

10 – **Alberto Vasco Uribe**. "Estructura y Proceso en la conceptualización de la enfermedad".

RESUMEN DETALLADO.

El texto de Alberto Vasco Uribe presenta una profunda revisión epistemológica de los fundamentos teóricos de la medicina contemporánea, estructurada en torno a una idea central: la necesidad de superar la concepción idealista de la salud y el modelo médico de causa y efecto simple, para pasar a entender la enfermedad como un proceso derivado de estructuras causales dinámicas donde lo biológico y lo social se articulan internamente de manera indisoluble.

Para desarrollar esta tesis, el autor comienza deconstruyendo el concepto teleológico de salud, tal como lo ha postulado históricamente la Organización Mundial de la Salud y gran parte de la tradición médica. Esta visión ahistórica, idealista y metafísica concibe a la salud como un estado original, estático y de perfección (la mera ausencia de enfermedad o el equilibrio absoluto). Vasco Uribe sostiene que esta definición no es inocua ni meramente técnica, sino que sirve de justificación ideológica para sostener el modelo médico hegemónico basado en la unicausalidad externa. Este modelo explicativo atribuye el origen de cualquier patología a una agresión única y aislada proveniente del exterior del individuo, ya sea un microorganismo, un trauma físico o un accidente. Al enfocar la atención en buscar siempre un "culpable" biológico externo, la medicina tradicional logra ocultar y despolitizar las condiciones materiales y sociales que realmente determinan el deterioro humano.

A medida que la ciencia evidenció las limitaciones de explicar padecimientos complejos con una sola causa (por ejemplo, el hecho de que no todas las personas expuestas al bacilo de Koch desarrollan tuberculosis), surgieron alternativas epidemiológicas como la multicausalidad y la tríada ecológica, que evalúa la interacción entre el agente, el huésped y el medio ambiente. Aunque estos modelos representaron un avance al incluir factores socioeconómicos y condicionantes, el autor advierte que siguen fallando en su matriz epistémica, ya que mantienen a lo social como un mero escenario de fondo o un factor ajeno a lo biológico, sin lograr una integración real.

Frente a esta insuficiencia, Vasco Uribe propone reconceptualizar la enfermedad a través de la noción de estructura causal dinámica. Bajo esta nueva perspectiva, la enfermedad deja de comprenderse como un evento estático o una simple invasión, para entenderse como un proceso histórico y cambiante. En este marco teórico, la antigua y determinística noción de "causa" es reemplazada por el concepto de factor de riesgo. Un factor de riesgo se entiende aquí como un elemento pasivo

(genético, conductual, ambiental o laboral) que, por sí solo, carece de la fuerza para enfermar; únicamente adquiere verdadero poder patógeno al articularse de forma específica con otros factores dentro de una estructura totalizante.

Esta propuesta metodológica es la que permite alcanzar la verdadera articulación biológico-social. Esto implica demostrar que determinantes como el modo de producción, la clase social o el estilo de vida no son un simple contexto externo que rodea al individuo, sino realidades que se inscriben, transforman y materializan directamente en su biología y fisiología. La manifestación concreta de la tremenda complejidad de estas interrelaciones es lo que el autor denomina efecto estructural. Reconocer la existencia de este efecto estructural obliga a la medicina a transformar su forma de diagnosticar: implica aceptar que las alteraciones ya no pueden ser siempre encasilladas en diagnósticos nosológicos unívocos y aislados, sino que deben ser abordadas como síndromes sistémicos y estudiadas a través de perfiles de morbilidad grupales.

En conclusión, abandonar el inmediatismo de la unicausalidad para abrazar la comprensión de la enfermedad como un proceso estructural y dinámico permite reorientar la práctica clínica y sanitaria, exigiendo abordajes interdisciplinarios que no solo persigan la aniquilación farmacológica de un agente patógeno aislado, sino la transformación profunda de las relaciones sociales y las condiciones de vida que enferman a las poblaciones.

Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

02 – Sandra Caponi. *Georges Canguilhem: del cuerpo subjetivo a la localización cerebral*.

RESUMEN DETALLADO

Título del texto analizado: *Georges Canguilhem: del cuerpo subjetivo a la localización cerebral*.

Autora: Sandra Caponi.

El artículo de Sandra Caponi propone una profunda revisión epistemológica de los discursos médicos y psiquiátricos contemporáneos, tomando como eje central el pensamiento del filósofo Georges Canguilhem. La idea fundamental que atraviesa el texto es que la concepción hegemónica de la salud mental, basada casi exclusivamente en la cuantificación estadística y la búsqueda anatómica, resulta insuficiente y reduccionista. Frente a este paradigma que aspira a medir de forma mecanicista el pensamiento y el dolor humano, la autora rescata la necesidad de integrar ineludiblemente al **cuerpo subjetivo**. Este concepto se refiere a la dimensión singular y en primera persona del individuo; es decir, la experiencia íntima e intransferible del sufrimiento, la impotencia o el placer, dimensiones que el discurso médico tradicional suele ignorar al tratar el organismo humano como un mero objeto observable en tercera persona.

Para comprender esta crítica, es fundamental analizar la distinción que hace Canguilhem entre la **normalidad bioestadística y la patología**. En el modelo biomédico predominante, la salud se define numéricamente: un rasgo o función es "normal" si se ajusta a los valores promedio de una población, y cualquier desvío se clasifica automáticamente como patológico o de riesgo. Sin embargo, Canguilhem invierte esta lógica argumentando que una anomalía o un desvío estadístico no constituyen por sí mismos una enfermedad. Lo patológico surge verdaderamente cuando el individuo experimenta un sentimiento directo de vida contrariada, una restricción de su libertad y una incapacidad para crear nuevas respuestas ante las exigencias de su entorno. Por ello, el autor postula la **salud como un concepto "vulgar"**, entendido no en el sentido de trivial o despectivo, sino como un fenómeno cotidiano, común, social y ajeno a las validaciones exclusivas de los laboratorios o las métricas de los aparatos. Desde esta perspectiva relacional, la salud mental no es la ausencia de conflictos ni un estado ideal de equilibrio químico, sino la capacidad dinámica y vital de una persona para reinventarse, asumir riesgos y sobreponerse a los fracasos que le impone su medio.

A pesar de la riqueza clínica y humana de esta visión integradora, Caponi advierte que la ciencia ha insistido históricamente en el camino opuesto a través de la

constante búsqueda de la **localización cerebral**. Desde la frenología del siglo XIX, que pretendía deducir características morales e intelectuales palpando las protuberancias del cráneo, hasta el actual uso de sofisticadas neuroimágenes (como el PET Scan o la resonancia magnética funcional), persiste una obstinación por ubicar físicamente el origen de las conductas, la voluntad y los padecimientos psíquicos en áreas específicas del cerebro. Esta pretensión neurocientífica parte de la premisa altamente cuestionable de que existe una equivalencia topográfica perfecta entre un proceso mental complejo y un mecanismo cerebral aislado, ignorando por completo que el pensamiento y el lenguaje humanos se construyen en una trama de interacciones sociales e históricas que no pueden ser delimitadas en una placa radiográfica.

En la actualidad, esta pasión localizacionista ha desembocado en un severo **reduccionismo psicofarmacológico y tecnológico**. Por un lado, se abusa de la falsa analogía que equipara el funcionamiento del cerebro humano con el de una computadora, olvidando que las máquinas procesan inventarios de datos pero carecen de capacidad reflexiva, intención o capacidad para formular significados. Por otro lado, la psiquiatría biológica opera bajo una lógica circular impulsada por la industria farmacéutica: el éxito de un medicamento dicta la etiología de la enfermedad. Así, si un fármaco actúa sobre un neurotransmisor y mitiga un síntoma, se concluye apresuradamente que el sufrimiento del paciente es causado únicamente por un déficit químico de dicha sustancia. Este modelo fomenta la medicalización masiva de problemas de la vida cotidiana, prometiendo "balas mágicas" químicas tanto para anular el dolor como para optimizar el rendimiento y el comportamiento. En última instancia, el texto no descarta los innegables beneficios de la fisiología o la neurología, sino que traza un límite ético indispensable: la construcción de la subjetividad, la creatividad y el sufrimiento no pueden clausurarse bajo el efecto de sinapsis o psicofármacos, pues la verdadera medida de la salud mental siempre requerirá de un sujeto capaz de otorgar sentido a su existencia en el mundo.

Teóricos y Prácticos. “Salud Pública y Mental” Cát.: TAJER.

09 – Débora Tajer. “**Cuidados generizados en salud**”.

RESUMEN DETALLADO.

El artículo de Débora Tajer postula que los cuidados en salud se encuentran profundamente "generizados", es decir, están atravesados por una división sexual del trabajo que asigna histórica e injustamente esta responsabilidad a las mujeres y feminidades. Para comprender esta problemática, la autora parte de la noción de cuidados como el conjunto de actividades físicas, simbólicas y de gestión que resultan indispensables para la reproducción social, esto es, para el sostenimiento de la vida cotidiana. Su abordaje desde la "economía del cuidado" devela cómo el sistema productivo y la sociedad en general se benefician enormemente de este trabajo, el cual se mantiene mayoritariamente no remunerado e invisibilizado. En este sentido, la "organización social del cuidado" —la forma en que se distribuyen las responsabilidades entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias— recae de manera desproporcionada sobre el ámbito familiar y, dentro de este, sobre las mujeres, consolidando el núcleo duro de la desigualdad. A esta matriz patriarcal es necesario sumarle la "interseccionalidad", un enfoque que articula el género con otras categorías de desigualdad como la clase socioeconómica, la etnia o el estatus migratorio. Esta mirada permite evidenciar que las mujeres de sectores vulnerables asumen la mayor carga de cuidados contando con la menor cantidad de recursos, lo que da lugar a fenómenos de desigualdad estructural como las cadenas migratorias de cuidado. Toda esta estructura determina un "proceso salud-enfermedad-cuidados (S-E-C) generizado", lo que significa que las asimetrías y los mandatos sociales establecen perfiles de morbilidad distintos, influyendo directamente en cómo varones, mujeres e identidades LGTBI+ viven, enferman, consultan al sistema sanitario y mueren. En el ámbito específico de la salud, este proceso se divide en dos grandes áreas. Por un lado, se encuentra la "producción institucional de los cuidados", referente a las prácticas realizadas dentro del sistema de salud formal. Allí opera una jerarquía donde las profesiones con menor poder económico y simbólico, pero más intensivas en tiempo y trato humano como la enfermería o el trabajo social, están altamente feminizadas; en contraste, las especialidades "capital intensivas" que utilizan mayor tecnología y generan mayores ingresos económicos siguen siendo dominadas por varones. Por otro lado, la "producción doméstica de los cuidados" abarca los servicios sanitarios no remunerados prestados al interior de los hogares, como la gestión de turnos médicos, el acompañamiento de personas mayores o la administración de tratamientos. Estas tareas, asumidas casi exclusivamente por las mujeres, generan una doble o triple jornada laboral que produce un severo desgaste físico y psíquico, agravado en la actualidad por los cambios demográficos que reducen el tamaño de

las familias y la cantidad de personas disponibles para cuidar. Como contrapartida a esta sobrecarga femenina, el texto analiza el impacto de la "masculinidad hegemónica" en el proceso de salud de los varones. Este modelo de socialización les exige cumplir estrictamente el rol de proveedores, inhibiendo su capacidad para registrar el malestar propio, alejándolos del aprendizaje de las tareas de cuidado y empujándolos a conductas de riesgo hacia sí mismos y hacia terceros para validar su virilidad. En consecuencia, los varones suelen evitar el sistema de salud ambulatorio y consultar únicamente cuando los cuadros clínicos revisten gravedad. Finalmente, la autora señala que la pandemia de COVID-19 no hizo más que amplificar todas estas vulnerabilidades preexistentes. Mientras la sobrecarga de tareas de reproducción social estalló sobre las mujeres (quienes acataron en mayor medida las normas de prevención), el déficit de autocuidado y la presunción de impunidad arraigada en privilegios de clase y género empujaron a muchos varones a desafiar las normas sanitarias, aumentando su exposición al virus. Ante este escenario, la conclusión ineludible es que toda política pública de salud debe incorporar la perspectiva de género para avanzar hacia la desfamiliarización, democratización y profesionalización de los cuidados, redistribuyendo equitativamente estas tareas esenciales para la vida.

Teóricos y Prácticos. “Salud Pública y Mental” Cát.: TAJER.

03 – Ceminari, Yanina; Stolkiner, Alicia. *“El cuidado social y la organización social del cuidado como categorías claves para el análisis de políticas públicas”*.

RESUMEN DETALLADO

Título del texto analizado: *“El cuidado social y la organización social del cuidado como categorías claves para el análisis de políticas públicas”*.

Autora: Ceminari, Yanina; Stolkiner, Alicia.

El artículo escrito por Yanina Ceminari y Alicia Stolkiner plantea que el cuidado de las personas mayores con dependencia debe dejar de ser concebido como un asunto exclusivamente privado, naturalizado y feminizado, para pasar a entenderse como una responsabilidad social, colectiva y de derechos. Para lograr esta transformación, las autoras proponen analizar las políticas públicas a través de una noción amplia e integral de "cuidado". A diferencia de la simple atención médica, el cuidado abarca todas las actividades materiales, simbólicas y de gestión que son indispensables para satisfacer las necesidades básicas y garantizar la reproducción de la vida en sociedad. Al abordar el cuidado desde el diseño de políticas públicas, se busca politizarlo, es decir, sacarlo de la esfera doméstica, donde históricamente ha recaído sobre las mujeres, para reconocerlo como una dimensión central del bienestar y la equidad de género.

Para evaluar cómo se distribuyen estas responsabilidades en una sociedad, el texto introduce tres categorías analíticas fundamentales. La primera es el modelo del "Social Care" o cuidado social, un enfoque que propone una visión transversal y multidimensional de los cuidados. Este modelo amplía el campo de acción al trasladar el cuidado desde el entorno familiar hacia el entorno social, convirtiéndolo en una cuestión de interés público y en una responsabilidad moral y colectiva. Para esquematizar esta distribución de responsabilidades, las autoras retoman la categoría del "Diamante del Cuidado", un marco analítico que visibiliza a los cuatro actores o vértices fundamentales que intervienen en la provisión de bienestar: el Estado, el mercado, la familia y la comunidad.

Sin embargo, dado que en América Latina existe un claro desequilibrio estructural entre estos vértices, se utiliza de manera complementaria la categoría de "Organización Social del Cuidado". Este concepto permite describir la configuración dinámica y a menudo desigual en la que interactúan estos cuatro actores, evidenciando que en la región la red familiar actúa como un vector de desigualdad al asumir desproporcionadamente la mayor parte de la carga frente al déficit de los servicios estatales. Esta sobrecarga responde a un modelo de "familiarización", un procedimiento de la política social mediante el cual la

responsabilidad principal del bienestar se delega a las familias y las redes de parentesco. Paralelamente, se observa un proceso de "mercantilización" cuando el acceso a los servicios de cuidado queda supeditado a la capacidad de compra de las personas en el sector privado.

Frente a este escenario de desigualdad, las autoras concluyen que el objetivo del diseño de políticas públicas, especialmente en el marco de normativas como la Ley Nacional de Salud Mental, debe orientarse hacia la "desfamiliarización" y la "desmercantilización" de los cuidados. Esto implica que el Estado asuma un rol protagónico para extraer el cuidado de las lógicas comerciales y derivarlo hacia las instituciones públicas, transformándolo en un derecho universal. De este modo, utilizar estas categorías de análisis permite desnaturalizar las injusticias actuales y promover una verdadera redistribución de las responsabilidades entre el Estado, el mercado, la familia y la comunidad, un paso indispensable para fomentar prácticas que protejan la autonomía y la salud mental tanto de las personas mayores como de quienes les asisten.

Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

05 – Menéndez. Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas.

RESUMEN DETALLADO

Título del texto analizado: Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas.

Autor: Eduardo L. Menéndez.

El artículo del antropólogo Eduardo L. Menéndez plantea una profunda revisión crítica sobre cómo se conciben y aplican las diferentes formas de curar en nuestras sociedades. Su idea central sostiene que, mientras el sector salud institucional suele ver los distintos saberes curativos de forma aislada y competitiva, en la realidad cotidiana los sujetos y grupos sociales articulan, mezclan y utilizan todos estos recursos de manera constante e intencional. Para comprender esta dinámica, el autor propone dejar de aislar a la salud y la enfermedad como meros eventos biológicos y abordarlos a través del concepto de **proceso salud/enfermedad/atención (s/e/a)**, el cual integra las dimensiones biológicas con las prácticas sociales, económicas y culturales que las personas emplean para resolver sus problemas de salud.

En las sociedades latinoamericanas actuales impera un **pluralismo médico**, es decir, la coexistencia simultánea de diversas formas de atención: la biomédica, la medicina popular y tradicional (curanderos, yerberos), las terapias alternativas o "New Age", y los grupos de autoayuda (como Alcohólicos Anónimos). Lejos de adherirse a un solo sistema por cuestiones puramente ideológicas, los individuos transitan por una **carrera del enfermo**. Esta trayectoria es un recorrido pragmático en el que el paciente y su microgrupo familiar buscan soluciones transitando de un curador a otro, cambiando de diagnóstico y de tratamiento según la evolución de la dolencia, los recursos económicos y su propia cultura.

Sin embargo, esta realidad relacional choca directamente con el **Modelo Médico Hegemónico (MMH)** o biomedicina. Este modelo, que representa la medicina alopática oficial, se caracteriza estructuralmente por su "biologismo" (reducir el padecimiento a una falla orgánica objetivable), su ahistoricidad y su exclusión sistemática de los factores socioculturales. El MMH tiende a establecer una relación médico-paciente asimétrica, donde la palabra y la experiencia del enfermo son subordinadas o ignoradas, mientras se fomenta una creciente medicalización de problemas cotidianos de la vida (convirtiendo eventos biológicos naturales, como el parto, en patologías o intervenciones quirúrgicas). Al validar sus prácticas

basándose exclusivamente en la racionalidad científica, la biomedicina suele estigmatizar, ignorar o subalternizar a los demás modelos de atención.

Frente a esta exclusión institucional, Menéndez rescata y posiciona a la **autoatención** como el proceso estructural, primario y más frecuente del sistema de cuidados. La autoatención engloba todas las representaciones y prácticas autónomas que el grupo doméstico (históricamente centralizado en el rol de la madre/esposa) utiliza para diagnosticar, aliviar, aguantar o curar un padecimiento antes, durante o después de acudir a un curador profesional. Es a partir de este núcleo familiar que se decide qué hacer y a quién consultar. Dentro de este amplio proceso existen dos dimensiones que la biomedicina suele confundir o separar interesadamente: el **autocuidado** y la **automedicación**. El autocuidado abarca las acciones preventivas e individualizadas (dietas, ejercicio, prevención) que la propia biomedicina promueve activamente. Por otro lado, la automedicación consiste en la decisión autónoma de consumir fármacos u otras sustancias para tratar un síntoma.

Es aquí donde el autor evidencia una enorme paradoja en el accionar del sector salud. Por un lado, la biomedicina condena severamente la automedicación, culpando a la "ignorancia" de la población por el uso indebido de fármacos (como los antibióticos) y la resistencia bacteriana. Por otro lado, esa misma biomedicina fomenta constantemente prácticas de autoatención y automedicación "legítimas", como enseñar a un paciente diabético a inyectarse insulina, promover el uso autónomo de anticonceptivos o instruir en la preparación de sueros de rehidratación oral. Menéndez señala que el sector salud ignora su propia historia al no reconocer que gran parte de los hábitos de automedicación de la población fueron aprendidos originalmente a través del contacto con los propios médicos en las consultas.

A modo de conclusión, el texto advierte que es estéril intentar prohibir la autoatención, ya que constituye un mecanismo vital de supervivencia y reproducción biosocial. En su lugar, el sector salud debe adoptar un **enfoque relacional** (o transaccional), dejando de ver a la autoatención como una amenaza. Las políticas públicas de salud deben articularse intencionalmente con los saberes populares, no para eximir al Estado de su responsabilidad económica y social de proveer servicios, sino para promover una co-atención real. Esto implica transitar hacia una relación médico-paciente más simétrica, donde en lugar de prohibir la automedicación, se asuma la tarea educativa de enseñar a la población a autoatenderse y automedicarse correctamente, reconociendo a los sujetos sociales como agentes activos y racionales en la gestión de su propia salud.

Teóricos y Prácticos. "Salud Pública y Mental" Cát.: TAJER.

06 – Michalewicz, Alejandro; Pierri, Carla; Ardila-Gómez, Sara. *"Del proceso de salud/enfermedad/atención, al proceso salud/enfermedad/cuidado: Elementos para su conceptualización"*.

RESUMEN DETALLADO

Título del texto analizado: *Del proceso de salud/enfermedad/atención, al proceso salud/enfermedad/cuidado: Elementos para su conceptualización*.

Autor: Michalewicz, Alejandro; Pierri, Carla; Ardila-Gómez, Sara.

El artículo elaborado por Alejandro Michalewicz, Carla Pierri y Sara Ardila-Gómez aborda el reciente viraje conceptual dentro del campo de la Medicina Social y la Salud Colectiva Latinoamericana, el cual ha modificado su objeto de estudio clásico, el "proceso salud/enfermedad/atención", para comenzar a denominarlo "proceso salud/enfermedad/cuidado". Este cambio terminológico busca superar las limitaciones del modelo médico tradicional al denotar un enfoque más integral, simétrico, participativo e intersectorial. Sin embargo, los autores advierten que la adopción de este término se ha producido sin una delimitación teórica clara, dando lugar a una polisemia, es decir, a una multiplicidad de sentidos que responden a posiciones técnico-políticas diversas e, incluso, antagónicas.

A través de una revisión de la literatura científica regional, el texto identifica cinco usos principales de la palabra "cuidado" en el ámbito sanitario. En primer lugar, se utiliza para referirse a la dimensión vincular y afectiva de las prácticas en salud, destacando el trato humano y emocional que suele quedar marginado por el uso excesivo de tecnologías biomédicas. En segundo lugar, denomina a las prácticas no formales, es decir, aquellas acciones preventivas o asistenciales que las familias y los individuos realizan por fuera de las instituciones, aunque este uso conlleva el riesgo de privatizar la responsabilidad del bienestar y eximir al Estado. En tercer lugar, el término se reivindica como sinónimo de atención integral, remitiendo a los principios originales de la Atención Primaria de la Salud donde prevalecen las relaciones horizontales y participativas. En cuarto lugar, el cuidado es entendido como el eje organizador de los servicios centrado en el usuario, proponiendo que las instituciones sanitarias vuelvan a priorizar a las personas por sobre los procedimientos técnicos. Finalmente, un quinto uso lo reduce a un mero sinónimo de "atención", lo cual vacía al concepto de su potencial crítico y transformador.

Frente a esta dispersión de significados, y reconociendo que los usos que apuntan a la integralidad y a la centralidad del usuario son los más afines a la Salud Colectiva, los autores proponen fundamentar el concepto apelando a los aportes del psicoanálisis y la psicología. Desde esta perspectiva interdisciplinaria, el

cuidado deja de ser una simple técnica sanitaria para erigirse como una condición humana fundamental y, sobre todo, como una "ética del cuidado". Esta dimensión ética debe orientar, preceder y presidir toda práctica en salud. Para conceptualizarla, el texto recurre a la noción de "ternura" desarrollada por el psicoanalista Fernando Ulloa, entendiéndola como la condición que hace posible alojar al otro. La ternura exige renunciar al apoderamiento del sujeto pasivo y genera dos pilares indispensables para el cuidado: la "empatía", que garantiza el suministro adecuado y el buen trato, y el "miramiento", que consiste en mirar con interés respetuoso a quien se reconoce como un sujeto ajeno, distinto y valioso por sí mismo.

En última instancia, esta ética del cuidado se sostiene inexorablemente sobre el principio de la dignidad humana. En un sistema de salud fuertemente mercantilizado y despersonalizado, concebir el "proceso salud/enfermedad/cuidado" exige reconocer al paciente como un semejante y un sujeto pleno de derechos, y no como un objeto de intervención, un instrumento o una mercancía. Es a partir de este posicionamiento ético relacional que las prácticas sanitarias pueden aspirar a transformar la realidad de los servicios, garantizando que quienes acuden a ellos dejen de sentirse vulnerables y desprotegidos, para pasar a sentirse seguros, informados, amparados y profundamente respetados.